Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50, Sala 1107, 11º andar - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent12vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5052362-60.2022.8.21.0001/RS

AUTOR: LORENZO SEARA BOHRER

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Relatório.

LORENZO SEARA BOHRER representado por sua genitora RAQUEL GONCALVES SEARA ajuizou a presente ação em face de UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA, todos já qualificados nos autos, sustentando, em síntese, que mantém contrato de prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e ambulatorial junto à ré. Alegou ser portador de rara canalopatia, associada à mutação do gene SCN1A, a qual acarreta convulsões, inicialmente motivadas por febre, afirmando que a síndrome começou quando tinha um ano e dois meses de idade. Asseverou que a primeira suspeita era de que se tratava de convulsões febris decorrentes da infância, com perspectiva de cessarem até os 5 anos, no entanto, passada esta idade, as convulsões permaneceram, de forma que ocorria tal síndrome sem febre, motivo pelo qual os remédios disponíveis não apresentavam a eficácia esperada. Assegurou que após o diagnóstico da síndrome, as convulsões pioraram, ao ponto de somente cessarem com medicação intravenosa, sendo que o único remédio capaz de controlar as crises é o Canabidiol 200mg/ml da indústria Prati Donaduzzi, na dose de 0,6 ml, duas vezes ao dia, resultando no uso de cerca de dois frascos por mês. Esclareceu que o referido remédio é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina e pela ANVISA, de forma que é regularmente comercializado nas farmácias. Sustentou que, solicitado o reembolso das medicações já compradas, bem como o posterior fornecimento do medicamento, a Unimed indeferiu os requerimentos ao argumento de ausência no rol de coberturas obrigatórias disposta na Resolução Normativa 428/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Discorreu acerca da regularidade e da vigência do contrato, bem assim defendeu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e Adolescente aos planos de saúde. Requereu, em sede liminar, que a ré forneça e se responsabilize por todos os custos do medicamento Canabidiol 200mg/ml, na dose de 0,6ml e na quantidade mensal determinada pela médica responsável, bem assim para que proceda ao ressarcimento os custos eventualmente suportados pela família do autor desde o ajuizamento da ação, sob pena de multa. Juntou documentos e efetuou o recolhimento das custas ao evento 3.

Foi deferido o pedido liminar para determinar que a ré ofereça cobertura de reembolso dos valores gastos pela aquisição do medicamento Canabidiol 200mg/ml (evento 4, DESPADEC1).

Opostos embargos de declaração pelo autor (evento 13, EMBDECL1), foram acolhidos para determinar que o reembolso deve ser de 100% do valor gasto aquisição do medicamento (evento 15, DESPADEC1).

A ré interpôs agravo de instrumento, o qual restou provido para cassar a decisão recorrida (evento 25, ACOR1).

Citada, a demandada contestou (evento 20, CONT1), sustentando que o plano do qual o autor é beneficiário exclui, expressamente, o fornecimento de quaisquer medicamentos para uso domiciliar, afirmando que a negativa não ocorreu por liberalidade da ré, mas sim porque o contrato firmado, em consonância com a RN 465/21, afasta a cobertura pretendida. Referiu que os únicos medicamentos concedidos em modalidade domiciliar são aqueles para uso oncológico, ao passo que o autor postula a cobertura para remédio de uso contínuo para tratamento domiciliar de Canalopatia, motivo pelo qual não merece amparo do convênio. Aduziu que a cobertura oferecida pelos planos de saúde não ocorre em razão da doença diagnosticada, mas dos procedimentos prescritos, conforme o rol da ANS. Alegou que a própria bula do remédio Canabidiol atesta a incerteza científica quanto à segurança e efetividade do fármaco para tratamento de qualquer doença, bem assim que este só pode ser compreendido de forma experimental, o que também afasta a cobertura. Discorreu acerca da legalidade das cláusulas contratuais e teceu considerações sobre o setor de saúde suplementar. Postulou a improcedência dos pedidos e juntou documentos.

Houve réplica (evento 26, RÉPLICA1).

Oportunizada a produção de provas (evento 27, ATOORD1), a parte ré nada requereu, enquanto a parte autora juntou novos documentos e requereu a produção de prova oral (evento 32, PET1 e evento 34, PET1), a qual foi indeferida (evento 36, DESPADEC1).

O autor apresentou novo pedido liminar (evento 47, PED LIMINAR_ANT TUTE1), indeferido no evento 50, DESPADEC1.

Convertido o julgamento em diligência (evento 71, DESPADEC1), sobreveio parecer do Ministério Público ao evento 75, PROMOÇÃO1, no qual opina o Parquet por julgamento de improcedência.

Os autos vieram conclusos para sentença.

Relatei.

Decido.

Fundamentação.

De início, consigno que os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos, conforme entendimento sumulado do STJ (súmula nº 608)[1].

Assentada tal premissa, tem-se que o autor é beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial denominado Unimax Coletivo Empresarial, com cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (evento 1, OUT7).

Na hipótese, o demandante foi diagnosticado com epilepsia associada a mutação no gene SCN1A (síndrome de Dravet), necessitando de tratamento para convulsões mediante uso do produto Canabidiol, 200mg/ml, da indústria Prati Donaduzzi, na dose de 0,7 ml, duas vezes ao dia, o que gera o uso de mais de 2 frascos por mês (evento 1, EXMMED8 e evento 1, LAUDO9).

Veja-se que a parte autora juntou comprovantes de pagamento ao evento 1, NFISCAL10, evidenciando os gastos pela aquisição do produto nas farmácias, o qual possui, em média, o valor de R$ 1.990,00.

Com efeito, sobreveio recusa de reembolso pela demandada, ao argumento de que a medicação solicitada não se encontra prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conforme segue colacionado (evento 1, OUT11):

> Prezado(a) Senhor(a),
>
> Em atendimento a solicitação de reembolso protocolada sob o número **35250120210120012798**, vimos pela presente esclarecer que **foi Indeferido.**
>
> No tocante à medicação ministrada de forma ambulatorial, esclarecemos que para medicação não oncológica ministrada de forma ambulatorial não possui previsão no Rol[1] de coberturas obrigatórias dispostas na Resolução Normativa 428/2018, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
>
> Sendo o que nos cumpria para o momento, colocamo-nos à disposição para prestar os esclarecimentos que se façam necessários.

Em relação à cobertura do plano de saúde, assim estabelece o contrato firmado com a Unimed (evento 20, OUT2):

> **CLÁUSULA SEGUNDA.** A amplitude dos serviços objeto do presente contrato abrange a cobertura de todos os procedimentos constantes do **plano-referência** de que trata o art. 10 e incisos I, II, e III, do art. 12, ambos da Lei nº 9.656/1998, conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (anexos da RN-ANS nº 338/2013).
>
> **Parágrafo Primeiro.** Além das coberturas constantes do plano-referência, a CONTRATADA será obrigada a garantir cobertura de doenças preexistentes, crônicas ou congênitas, sendo vedado o estabelecimento de qualquer cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT).

Depreende-se, portanto, que há expressa exclusão de cobertura de medicamento experimental, bem assim de qualquer tipo de medicamento para tratamento domiciliar, consoante Cláusula Nona:

> **CLÁUSULA NONA.** A CONTRATADA não será obrigada a responsabilizar-se pela cobertura ou prestação dos seguintes serviços:
>
> a) tratamentos clínicos e cirúrgicos experimentais;
>
> b) procedimentos clínicos, cirúrgicos, órteses e próteses para fins estéticos;
>
> c) inseminação artificial;
>
> d) tratamentos de rejuvenescimento ou emagrecimento com finalidade estética;
>
> e) fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, bem como todo e qualquer tipo de medicamento para tratamento domiciliar;
>
> f) fornecimento de próteses, órteses e acessórios quando não ligado ao ato cirúrgico;
>
> g) tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;
>
> h) casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente;
>
> i) procedimentos odontológicos;
>
> j) atendimento domiciliar.

Da mesma forma, prevê os arts. 17 e 18 da Resolução Normativa 465/21, *in verbis*:

Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. ***São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:***

VI - fornecimento de ***medicamentos para tratamento domiciliar****, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;*

Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.º 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou

procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para:

X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características:

Além disso, atesta a bula do Canabidiol da indústria Prati Donaduzzi, 200mg/ml, in verbis (evento 20, OUT3):

2. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE PRODUTO?
Advertências quanto ao uso do produto
Este produto não substitui o uso de medicamentos registrados.
Este produto não possui os estudos clínicos completos que comprovam a sua eficácia e segurança.
Há incertezas quanto à segurança à longo prazo do uso dos produtos de Cannabis como terapia médica.

Nesse sentido, aliás, o teor do acórdão que cassou a decisão liminar do evento 04 (evento 25, ACOR1), *in verbis*:

Não fosse isso, veja que o Canabidiol, ainda se encontra em fase de experimentação ***sendo considerado apenas um produto****, não podendo ser conceituado como medicamento:*

O canabidiol só pode ser utilizado a partir de um determinado tipo de receita médica (tipo B) e somente no caso de esgotamento de outros tratamentos, conforme determina a legislação para o tema.

Ainda de acordo com o regramento da Anvisa, essas substâncias são produtos, e não medicamentos. Isso porque neste último caso precisa haver estudos clínicos que comprovem a eficácia das substâncias[2].

Até o momento, argumenta a Anvisa, as pesquisas científicas ainda não desenvolveram métodos para aferir as evidências e informações suficientes para que tais produtos sejam considerados medicamentos.

Então, a flexibilização por parte da Anvisa, para utilização do produto pleiteado, é para que possa ser importado e ser utilizado em alguns casos excepcionais, pois se não fosse esse entendimento, o Canabidiol sequer poderia ser utilizado no Brasil pois sua principal substância ativa é a base de Cannabis Sativa. Vejamos:

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou autorização sanitária para um novo produto à base de cannabis com a participação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), produzido pela empresa Prati, Donaduzzi e Cia. O preparado foi denominado Canabidiol Farmanguinhos 200 mg/mL.

O produto tem administração por via oral e é composto de 200 mg/ml de CBD, um dos princípios ativos da Cannabis sativa e de até 0,2% de THC (tetra-hidrocanabinol, o principal componente psicoativo da planta). O pedido foi feito pela Fiocruz em março deste ano. De acordo com a Anvisa, a análise levou 35 dias no total[3].

No caso em tela, conforme a Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Complementar, o produto solicitado pelo autor não está previsto no rol de coberturas obrigatórias, cumprindo fazer ver que, nos termos dos artigos 17 e 18 da referida Resolução, tem-se ainda a expressa exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, cuja cobertura é assegurada apenas aos medicamentos antineoplásicos, hipótese que não é a dos autos.

Nesse sentido o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DO ROL DA ANS. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. - A autora postula o fornecimento do fármaco ***canabidiol*** *indicado pelo médico para tratamento de epilepsia refratária, moléstia que a acomete, havendo recusa de fornecimento por parte do agravante sob o fundamento de que contratualmente não está obrigado a fornecer e que ainda não consta no rol da ANS. - O cerne da questão nesse processo é a obrigação legal ou contratual apta a justificar que um plano de saúde privado seja compelido a fornecer um medicamento a que não está obrigado. O contrato de plano de saúde é decorrente da autonomia privada dos particulares, com algumas cláusulas impostas pela ANS. -* ***O fármaco postulado pela autora não consta no rol da ANS e, ainda, se encontra em fase de coleta de evidencias e informações para ser considerado medicamento.*** *AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51325546620218217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 18-11-2021)*

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. EPILEPSIA (CID10 G 40.2) E ESCLEROSE TUBEROSA (CID G40.2). ***CANABIDIOL****. MEDICAMENTO 1PURE CDB 6000MG/30ML, PARA USO DOMICILIAR. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBERTURA DO MEDICAMENTO INDEVIDA (...) No caso em comento, incontroverso nos autos que o menor é portador de patologias neurológicas e progressivas, dentre elas epilepsia grave (CID10 G 40.2) e Esclerose Tuberosa (CID G40.2), necessitando do uso de medicamento a base de* ***canabidiol*** *-1pure CDB 6000mg/30ml, nos termos do laudo médico acostado no evento 1 laudo7, cuja cobertura foi negada pela requerida, sob o argumento de que tal medicamento não consta no rol da ANS, bem como de que não há cobertura para medicamento de uso domiciliar.* ***Em que pese sensível à situação do autor, a situação telada não se enquadra nas exceções que permitem a concessão dos medicamentos domiciliares, de modo que é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).*** *Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA (Apelação Cível, Nº 50385935320208210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-02-2022) (g.n.)*

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE. 1)

Tratando-se de contrato regulamentado, devem ser observadas as coberturas mínimas definidas na Resolução Normativa nº 428/2017, atual RN 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), que apresenta Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a qual não pode prever aquelas excetuadas no artigo 10 da Lei nº 9.656/98 e, também, não pode excluir ou mitigar as hipóteses do artigo 12 do mesmo diploma legal. 2) ***É lícito que se excetue o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar - administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (não abrangido o home care) -, salvo os antineoplásicos, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente (Arts. 10, incs. V e VI e 12, da Lei nº 9.656/98). 3) A vedação constante no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, voltada à operadora de plano de saúde, não obsta que, na contratação, atendidos os requisitos regulatórios, as partes incluam dentre as coberturas obrigatórias os medicamentos de uso domiciliar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade, relativo à liberdade contratual. Ademais, é possível a contratação acessória de cobertura de medicamentos domiciliares, de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. 4) Caso dos autos em que o medicamento postulado, PRATI-DONADUZZI" à base de Canabidiol, indicado para o tratamento de epilepsia de difícil controle, embora possua registro na Anvisa, é de uso domiciliar. 5) Considerado que não há no contrato principal previsão acerca da obrigatoriedade de cobertura de medicamentos domiciliares, bem como que não há notícias de contratação acessória, nos termos da RN 310/2012, descabe compelir a operadora do plano de saúde à cobertura do medicamento domiciliar postulado.*** *Alteração de posição em atenção aos recentes julgados da Corte Superior (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). 6) Ausente probabilidade do direito, elemento necessário à concessão da tutela de urgência. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 51033175020228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 28-07-2022)*

Nesse contexto, inviável o acolhimento da pretensão como formulada, na esteira do parecer ministerial.

Dispositivo.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão, resolvendo o mérito forte no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios advogado ao procurador da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da causa conforme art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive o MP.

Decorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA DORIGONI HARTMANN, Juíza de Direito**, em 16/2/2024, às 15:13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10054186206v55** e o código CRC **c572cda2**.

---

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. ↩
2. https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-05/anvisa-autoriza-produto-base-de-cannabis-em-projeto-com-fiocruz ↩
3. https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-05/anvisa-autoriza-produto-base-de-cannabis-em-projeto-com-fiocruz ↩